Health Assessment
تقييم صحي

LECTURE 5 · المحاضرة 5

تقييم القلب وأوعية الرقبة — بنك الأسئلة

Heart and Neck Vessels Assessment — Exam & Questions

المرحلة الثانية

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسن علي

LEC 5

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Preparation — التحضير

EN **To evaluate the carotid arteries, the client can be:** Q1

AR س1. لتقييم الشريانين السباتيين يمكن أن يكون المريض:

A Prone منبطحًا
B Sitting جالسًا
C Standing on one leg واقفًا على ساق
D In Trendelenburg بوضع ترندلنبرغ

EN **To assess the jugular vein & pericardium, the client should be:** Q2

AR س2. لتقييم الوداجي والتامور يجب أن يكون المريض:

A Sitting upright جالسًا منتصبًا
B Prone منبطحًا
C Supine with head and chest slightly elevated مستلقيًا مع رفع الرأس والصدر قليلًا
D Standing واقفًا

EN **The examiner stands on the client's:** Q3

AR س3. يقف الفاحص على جانب المريض:

A Left side الأيسر
B Head end عند الرأس
C Foot end عند القدمين
D Right side الأيمن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Carotid artery — الشريان السباتي

EN The carotid artery is palpated: **Q4**

AR س4. يُجسّ الشريان السباتي:

- **A** One at a time, gently, medial to the sternomastoid — واحدًا في كل مرة بلطف إلى الداخل من القصية الخشائية
- **B** Lateral to the sternomastoid — إلى الخارج من القصية الخشائية
- **C** Over the carotid sinus with pressure — فوق الجيب السباتي بضغط
- **D** Both sides together firmly — الجانبان معًا بقوّة

EN The normal carotid pulse strength is: **Q5**

AR س5. قوّة النبض السباتي الطبيعية:

- **A** 0
- **B** 2+ or moderate — 2+ أو متوسطة
- **C** 1+ weak — 1+ ضعيفة
- **D** 4+ bounding — 4+ قافزة

EN The normal carotid contour is: **Q6**

AR س6. الشكل الطبيعي للنبض السباتي:

- **A** Slow upstroke & rapid downstroke — صعود بطيء ونزول سريع
- **B** Absent — غائب
- **C** Irregular — غير منتظم
- **D** Smooth with rapid upstroke & slower downstroke — أملس بصعود سريع ونزول أبطأ

EN The carotid artery is auscultated with: **Q7**

AR س7. يُصغى إلى الشريان السباتي بـ:

- **A** The bell lightly — الجرس بخفّة
- **B** The palm — راحة اليد
- **C** The diaphragm firmly — الغشاء بإحكام
- **D** No stethoscope — بلا سمّاعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The three levels of carotid auscultation include all EXCEPT:** Q8

AR س8. مستويات إصغاء السباتي الثلاثة تشمل كل ما يلي عدا:

A Angle of jaw زاوية الفك

B Mid-clavicular area منطقة منتصف الترقوة

C Apex of the heart قمّة القلب

D Base of the neck قاعدة الرقبة

Jugular venous pulse النبض الوداجي

EN **For the jugular venous pulse, the client is supine at:** Q9

AR س9. لفحص النبض الوداجي يستلقي المريض بزاوية:

A 60-70 degree 60-70 درجة

B 0 degree 0 درجة

C 90 degree 90 درجة

D 30-40 degree 30-40 درجة

EN **The pillow is removed during the JVP exam to:** Q10

AR س10. تُزال الوسادة أثناء فحص الوداجي لـ:

A Increase comfort زيادة الراحة

B Avoid flexing of the neck تجنّب ثني الرقبة

C Lower blood pressure خفض الضغط

D Hear murmurs سماع النفخات

EN **Normal internal jugular pulsation is seen:** Q11

AR س11. يُرى نبض الوداجي الداخلي الطبيعي:

A 3 cm above the sternal angle 3 سم فوق الزاوية القصّية

B 10 cm above the clavicle 10 سم فوق الترقوة

C At the angle of the jaw عند زاوية الفك

D At the apex عند القمّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a feature of the jugular pulse (not carotid)?** Q12

AR س12. أيّها صفة للنبض الوداجي (لا السباتي)؟

A Palpable يُجسّ

B Does not change with position لا يتغيّر مع الوضعية

C Disappears on palpation يختفي عند الجسّ

D Crest unchanged with inspiration القمّة لا تتغيّر مع الشهيق

EN **The carotid pulse, unlike the jugular pulse:** Q13

AR س13. النبض السباتي بخلاف الوداجي:

A Is palpable يُجسّ

B Disappears when upright يختفي عند الانتصاب

C Disappears with pressure above clavicle يختفي بالضغط فوق الترقوة

D Drops with deep inspiration ينخفض مع الشهيق العميق

Pericardium التامور

EN **When visible, the apical impulse occupies the:** Q14

AR س14. عندما يُرى النبض القمّي يشغل:

A 2nd ICS المسافة الثانية

B 4th or 5th ICS المسافة الرابعة أو الخامسة

C 7th ICS المسافة السابعة

D 3rd ICS only الثالثة فقط

EN **The normal size of the apical impulse is:** Q15

AR س15. الحجم الطبيعي للنبض القمّي:

A 3cm x 4cm 4×3 سم

B 0.5 cm 0.5 سم

C 1cm x 2cm 2×1 سم

D 5 cm 5 سم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal duration of the apical impulse:** Q16

AR س16. المدّة الطبيعية للنبض القمّي:

A Throughout systole طوال الانقباض

B During diastole أثناء الانبساط

C Second half of systole النصف الثاني من الانقباض

D Short, first half of systole قصيرة، النصف الأول من الانقباض

EN **The apical impulse may not be palpable in:** Q17

AR س17. قد لا يُجسّ النبض القمّي عند:

A Obese clients or thick chest wall البدينين أو ذوي جدار الصدر السميك

B Thin clients النحيفين

C Children الأطفال

D Sitting clients الجالسين

EN **The apical impulse is palpated using:** Q18

AR س18. يُجسّ النبض القمّي باستعمال:

A The whole palm راحة اليد كاملة

B One finger pad باطن إصبع واحد

C The ulnar edge الحافة الزندية

D The stethoscope السمّاعة

EN **Cardiac percussion starts at the:** Q19

AR س19. يبدأ قرع القلب عند:

A 2nd ICS right المسافة الثانية يمينًا

B Apex with the bell القمّة بالجرس

C 5th ICS on the left near the anterior axillary line المسافة الخامسة يسارًا قرب الخط الإبطي الأمامي

D Xiphoid الناتئ الرهابي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Auscultation — الإصغاء

EN The normal heart rate in the lecture is: **Q20**

AR س20. معدّل القلب الطبيعي في المحاضرة:

- **A** 40-60 b/min — 40-60/د
- **B** 100-120 b/min — 100-120/د
- **C** 120-160 b/min — 120-160/د
- **D** 60-100 b/min — 60-100/د

EN At the apex: **Q21**

AR س21. عند القمّة:

- **A** S1 is louder than S2 — S1 أعلى من S2
- **B** S2 is louder than S1 — S2 أعلى من S1
- **C** Both are absent — كلاهما غائب
- **D** S3 is loudest — S3 الأعلى

EN At the base: **Q22**

AR س22. عند القاعدة:

- **A** S1 is louder than S2 — S1 أعلى من S2
- **B** S2 is louder than S1 — S2 أعلى من S1
- **C** No sounds — لا أصوات
- **D** Only murmurs — النفخات فقط

EN To listen for murmurs at the apex, the client is rolled to the left side and the examiner uses: **Q23**

AR س23. لسماع النفخات عند القمّة يُدار المريض لليسار ويستعمل الفاحص:

- **A** The diaphragm firmly — الغشاء بإحكام
- **B** The palm — راحة اليد
- **C** Percussion — القرع
- **D** The bell — الجرس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Normally, murmurs:** Q24

AR س24. طبيعيًا النفخات:

A Are loud at the base عالية عند القاعدة

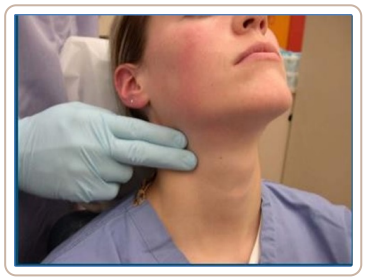
B Are heard at the apex تُسمع عند القمّة

C Should not be heard يجب ألّا تُسمع

D Increase on exhale تزداد مع الزفير

EN **Picture: this test is the:** Q25

AR س25. صورة: هذا الفحص هو:



A Tracheal palpation جسّ الرغامى

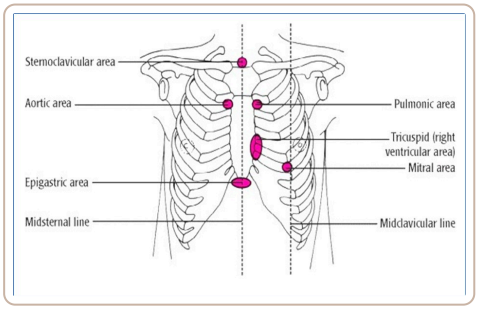
B Thyroid palpation جسّ الدرقية

C Lymph node palpation جسّ العقد اللمفاوية

D Carotid artery palpation جسّ الشريان السباتي

EN **Picture: this figure shows:** Q26

AR س26. صورة: يوضّح هذا الشكل:



A Respiratory landmarks المعالم التنفّسية

B Auscultation areas of the precordium مناطق الإصغاء أمام القلب

C Lymph nodes العقد اللمفاوية

D Rib fractures كسور الأضلاع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Both carotid arteries are palpated at the same time.

AR يُجسّ الشريانان السباتيان في الوقت نفسه.

True · صح False · خطأ

2 EN Avoid excessive pressure on the carotid sinus area.

AR تجنّب الضغط المفرط على منطقة الجيب السباتي.

True · صح False · خطأ

3 EN Carotid findings should be the same bilaterally.

AR يجب أن تكون نتائج السباتي متماثلة في الجانبين.

True · صح False · خطأ

4 EN A sound is normally heard over the carotid artery.

AR يُسمع صوت طبيعيًا فوق الشريان السباتي.

True · صح False · خطأ

5 EN The jugular pulse disappears with pressure above the clavicle.

AR يختفي النبض الوداجي بالضغط فوق الترقوة.

True · صح False · خطأ

6 EN The carotid pulse crest drops with deep inspiration.

AR تنخفض قمّة النبض السباتي مع الشهيق العميق.

True · صح False · خطأ

7 EN The apical impulse occupies only one interspace.

AR يشغل النبض القمّي مسافة وربية واحدة فقط.

True · صح False · خطأ

8 EN Pulsations across the precordium are normal.

AR النبض عبر المنطقة أمام القلب طبيعي.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN At the 2nd interspace the border of cardiac dullness coincides with the left sternal border.

AR عند المسافة الثانية تنطبق حافة الأصمّية على الحافة اليسرى للقصّ.

True · صح False · خطأ

10 EN The heart rhythm is normally regular.

AR إيقاع القلب منتظم طبيعيًا.

True · صح False · خطأ

11 EN Heart auscultation begins with the bell end piece.

AR يبدأ إصغاء القلب بقطعة الجرس.

True · صح False · خطأ

12 EN The end pieces of the stethoscope are cleaned with an alcohol swab.

AR تُنظَّف قطع السمّاعة بمسحة كحول.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Jugular vs carotid pulse

AR النبض الوداجي مقابل السباتي

2 EN S1 vs S2

AR S1 مقابل S2

3 EN Bell vs diaphragm

AR الجرس مقابل الغشاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Carotid sitting vs jugular supine 4

AR السباتي جالسًا مقابل الوداجي مستلقيًا

EN Apical impulse location 5

AR موضع النبض القمّي

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the subjective data of heart and neck vessels assessment. 1

AR عدّد البيانات الذاتية لتقييم القلب وأوعية الرقبة.

EN Describe palpation of the carotid artery and its normal findings. 2

AR صف جسّ الشريان السباتي ونتائجه الطبيعية.

EN How do you distinguish a jugular pulse from a carotid pulse? 3

AR كيف تميّز النبض الوداجي عن السباتي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Give the normal characteristics of the apical impulse. 4

AR اذكر الخصائص الطبيعية للنبض القمّي. 4

EN Describe heart auscultation and its normal findings. 5

AR صف إصغاء القلب ونتائجه الطبيعية. 5

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 B	6 D	7 A	8 C
9 D	10 B	11 A	12 C	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 D	24 C
25 D	26 B						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Jugular vs carotid pulse**

Jugular: often visible, disappears on palpation, when upright and with pressure above clavicle, crest drops with deep inspiration. Carotid: not clearly visible, palpable, unchanged by position, pressure or inspiration.

AR **النبض الوداجي مقابل السباتي**

الوداجي: مرئي غالبًا، ويختفي بالجسّ وبالانتصاب وبالضغط فوق الترقوة، وتنخفض قمّته مع الشهيق.
السباتي: غير مرئي بوضوح، ويُجسّ، ولا يتغيّر بالوضعية أو الضغط أو الشهيق.

2

EN **S1 vs S2**

S1 is louder at the apex; S2 is louder at the base.

AR **S1 مقابل S2**

S1 أعلى عند القمّة، وS2 أعلى عند القاعدة.

3

EN **Bell vs diaphragm**

Bell: lightly over the carotid and at the apex for murmurs. Diaphragm: rate, rhythm, S1/S2, and firmly at the base for murmurs.

AR **الجرس مقابل الغشاء**

الجرس: بخفّة فوق السباتي وعند القمّة للنفخات. الغشاء: المعدّل والإيقاع وS1/S2، وبإحكام عند القاعدة للنفخات.

4

EN **Carotid sitting vs jugular supine**

Carotids can be evaluated sitting; jugular vein and pericardium need supine with head and chest slightly elevated (30-40 degree for JVP).

AR **السباتي جالسًا مقابل الوداجي مستلقيًا**

يمكن تقييم السباتي جالسًا، أما الوداجي والتامور فيحتاجان استلقاءً مع رفع الرأس والصدر (30-40 درجة للوداجي).

5

EN **Apical impulse location**

4th or 5th ICS, at or medial to the MCL — not lateral to it.

AR **موضع النبض القمّي**

المسافة الرابعة أو الخامسة، على خط منتصف الترقوة أو داخله — لا خارجه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the subjective data of heart and neck vessels assessment.**

Chest pain; cough; edema; family history; dyspnea; fatigue; nocturia; personal habits; orthopnea; cyanosis; past cardiac history.

AR **عدّد البيانات الذاتية لتقييم القلب وأوعية الرقبة.**

ألم الصدر؛ والسعال؛ والوذمة؛ والتاريخ العائلي؛ وضيق النفس؛ والتعب؛ والتبوّل الليلي؛ والعادات الشخصية؛ وضيق النفس الاضطجاعي؛ والزرقة؛ والتاريخ القلبي السابق.

2

EN **Describe palpation of the carotid artery and its normal findings.**

Palpate each carotid medial to the sternomastoid, gently, one at a time, avoiding excessive pressure on the carotid sinus; feel contour and amplitude and compare sides. Normal: smooth contour with rapid upstroke and slower downstroke; strength 2+ or moderate; same bilaterally.

AR **صف جسّ الشريان السباتي ونتائجه الطبيعية.**

يُجسّ كل سباتي إلى الداخل من القصية الخشائية بلطف وواحدًا في كل مرة مع تجنّب الضغط على الجيب السباتي؛ ويُتحسّس الشكل والسعة وتُقارن الجهتان. الطبيعي: شكل أملس بصعود سريع ونزول أبطأ؛ وقوّة 2+؛ ومتماثل.

3

EN **How do you distinguish a jugular pulse from a carotid pulse?**

Jugular: often visible; disappears on palpation; disappears when upright; disappears with pressure above clavicle; crest level drops with deep inspiration. Carotid: not clearly visible; palpable; does not change with position; no change with pressure above clavicle; crest unchanged with deep inspiration.

AR **كيف تميّز النبض الوداجي عن السباتي؟**

الوداجي: مرئي غالبًا؛ ويختفي بالجسّ وبالانتصاب وبالضغط فوق الترقوة؛ وتنخفض قمّته مع الشهيق العميق.
السباتي: غير مرئي بوضوح؛ ويُجسّ؛ ولا يتغيّر بالوضعية أو بالضغط فوق الترقوة؛ ولا تتغيّر قمّته مع الشهيق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Give the normal characteristics of the apical impulse.** 4

Location: one interspace, the 4th or 5th, at or medial to the MCL; size 1cm x 2cm; amplitude a short gentle tap; duration short, first half of systole. It is not palpable in obese clients or thick chest wall.

AR **اذكر الخصائص الطبيعية للنبض القمّي.**

الموضع: مسافة واحدة، الرابعة أو الخامسة، على خط منتصف الترقوة أو داخله؛ والحجم 1×2 سم؛ والسعة نقرة قصيرة لطيفة؛ والمدّة قصيرة في النصف الأول من الانقباض. ولا يُجسّ عند البدين أو جدار الصدر السميك.

EN **Describe heart auscultation and its normal findings.** 5

Clean the end pieces; begin with the diaphragm: rate 60-100 b/min, regular rhythm; S1 louder than S2 at the apex and S2 louder than S1 at the base. For murmurs: roll the client to the left side and listen with the bell at the apex, then sit up leaning forward and exhaling and listen with the diaphragm firmly at the base; murmurs should not be heard.

AR **صف إصغاء القلب ونتائجه الطبيعية.**

تُنظّف القطع، ويُبدأ بالغشاء: المعدّل 60-100/د والإيقاع منتظم؛ وS1 أعلى عند القمّة وS2 أعلى عند القاعدة. للنفخات: يُدار المريض لليسار ويُستمع بالجرس عند القمّة، ثم يجلس مائلًا ويزفر ويُستمع بالغشاء بإحكام عند القاعدة؛ ويجب ألّا تُسمع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t